Unité d'enseignement intégrée 2
2024 2025

Sémiologie neurologique: signes physiques:
Etude de la vigilance et des fonctions cognitives, la station debout, la marche

Dr CHIBANI

Introduction

- L'examen neurologique est difficile et vaste
- IL doit être fait systématiquement au cours de tout examen clinique complet.

- Interrogatoire
- Examen clinique

Buts

- reconnaître les **symptômes**
- grouper les **symptômes en syndromes**
- localiser le **siège de la lésion : topographie**
- orienter les **examens complémentaires**

Moyens

- Marteau réflexe
- Coton hydrophile
- Aiguille
- Diapason
- Abaisse langue
- Tubes à eau froide & chaude
- Lampe de poche
- Ophtalmoscope



Conditions d’examens

- Examen dans le calme, pièce éclairée
- Collaboration du patient
- Explication claires des manouvres
- S’assurer que le patient entend parfaitement les questions
- Le patient doit être interrogé dans la langue qu'il parle couramment

Interrogatoire

- **Motif de consultation**
  - Douleur -céphalée → intensité Topographie Type
  - Les troubles **sensoriels (vue, odorat…)**
  - perte de connaissance
  - fatigabilité d'un hémicorps
  - aphasie
  - perte /Trouble de sensibilité paresthésies
  - tremblement
  - Trouble de la marche / station debout
  - Trouble sphinctériens miction -génitaux impuissance

- **Circonstances d'apparition du symptôme**
  - Effort physique
  - Sommeil
  - traumatisme crânien

Interrogatoire

Mode de début

- Brutal / progressif
- progressif: rapidement/ lentement progressif

- Traumatique → Brutal
- Vasculaire → Brutal
- Tumoral → Progressif
- Dégénératif → Très lentement progressif

- Métabolique → Généralement lent *EX hyponatrémie*
- Infectieux → Rapidement progressif + syndrome infectieux

- **Histoire de la maladie**
  - date du début
  - évolution des symptômes dans le temps
  - traitement reçu
- **Antécédents**
  - Personnels: affection neurologique ou autres
  - Familiaux : les cas similaires

Vigilance

- Le premier contact avec le patient permet de définir l'état de la conscience : le patient vous suit-il du regard ? Réagit-il à votre présence, répond-il à vos questions ? Connaît-il son nom, l'endroit où il se trouve, la date du jour ?
- Ainsi on peut constater :
  - Un syndrome confusionnel ou
  - Un coma

Une confusion mentale : est une baisse importante de la vigilance qui est fluctuante selon les moments de la journée avec désorientation temporo-spatiale, trouble du jugement et du raisonnement.

Un coma :

Il s'agit d'une Perte prolongée partielle ou totale de l'état de conscience et de la vigilance

Le patient comateux semble endormi, Il n'interagit pas avec l'environnement et ne répond pas de façon adaptée aux stimulations (verbales ou tactiles)

Le score de Glasgow :

- **Ouverture des yeux Score**
- _ Spontanée **4**
- _ Sur ordre oral **3**
- _ Après stimulations douloureuses **2**
- _ Aucune **1**
- **Meilleure réponse motrice**
- _ Exécute un ordre **6**
- _ Chasse les stimuli nociceptifs **5**
- _ Simple réponse de retrait **4**
- _ Réponse en flexion stéréotypée **3**
- _ Réponse en extension **2**
- _ Pas de réponse **1**

- **Réponse verbale**
- _ Claire et adaptée **5**
- _ Conversation confuse **4**
- _ Mots inappropriés **3**
- _ Mots incompréhensibles **2**
- _ Aucun mot **1**

Les valeurs du score sont comprises entre **3 et 15**. On définit le coma profond pour un score inférieur ou égal à 8.

Etude des fonctions cognitives :

Les différents comportements spécifiques à l'espèce humaine, tel que:

- la mémoire
- le langage,
- les praxies (c'est la capacité d'effectuer un geste précis) et
- les gnosies (c'est la faculté de reconnaître un objet par l'un des sens).

Un test simple: le mini-mental status, permet une évaluation rapide des fonctions cognitives du patient.

a) Les principaux troubles de mémoire :

- **Amnésie antérograde :** impossibilité de fixation de souvenirs nouveaux alors que les données de l'enfance sont conservées, désorientation temporo-spatiale **et anosognosie →méconnaissance du trouble.**
- **Amnésie rétrograde :** oubli portant sur les évènements qui précèdent l'épisode pathologique**.**
- **Amnésie lacunaire :** amnésie focale (trou) dans les souvenirs du patient, vue au cours des traumatismes crâniens

Autres troubles cognitifs

- L'orientation dans le temps et l'espace
- La capacité d'attention et de concentration : elle est estimée par le degré d'adhésion à la conduite de l'examen, par la répétition de listes de chiffres, par des exercices de calcul mental simples, Nommer des objets

- Le jugement: on recherche une perte de la critique, une incapacité à formuler une opinion autonome et adéquate à la situation, une impossibilité à critiquer les histoires absurdes.
- Le raisonnement: sa capacité est jugée par la possibilité de résoudre des problèmes simples, d'interpréter correctement un proverbe, sur la capacité à extraire des similitudes ou des différences.

b) Les principaux troubles du langage :

- On étudiera l'expression et la compression du langage oral et écrit.
- **L'Aphasie** : trouble de l'expression et de la compréhension du langage secondaire à une lésion cérébrale focale en dehors de tout état démentiel, déficit sensoriel ou anomalies de l'appareil phonatoire.
- **Aphasie de Wernicke** : **aphasie sensorielle** : la lésion est temporale postérieure. Le langage spontané est abondant et inapproprié (**para**phasie). Parfois est réalisé un véritable jargon totalement incompréhensible. **La compréhension** est totalement **perturbée**, Le malade n'a pas conscience de son trouble **(anosognosie).**
- **Aphasie de Broca : aphasie motrice** la lésion siège dans le lobe frontal. Le malade parle peu, avec hésitation. Le langage spontané est pauvre, le vocabulaire restreint et les phrases courtes. (Trouble de l'expression) .Il est conscient de son trouble. L'écriture et la lecture sont altérées.

c) Les apraxies

- L'apraxie est l'impossibilité d'élaborer une activité motrice complexe utilisant ou non des objets. Le patient ne comprend plus **(**Le malade ne sait plus faire les gestes demandés)**.**

A. **Idéomotrice: geste simple**
B. **Idéatoire: geste complexe avec objet**
C. **Géométrique: dessin graphique**
D. **De l'habillage: problème dans l'utilisation des vêtements**

d) Les agnosies

- Ce sont des troubles de la reconnaissance des objets connus et familiers survenant pour une modalité sensorielle donnée en l'absence d'un déficit sensoriel, d'une détérioration globale des fonctions supérieures, d'un trouble de la conscience ou de l'attention.
- 3 sens : auditive, tactile, visuel
- **L'astéréognosie:** désigne l'incapacité à reconnaître un objet en utilisant uniquement le sens du tact.
- **Anosognosie** : non reconnaissance par le malade de sa maladie

Etude de la marche et la station debout

I. La posture

- **La position debout** : est étudiée en demandant au sujet de se tenir debout, les pieds joints, les bras le long du corps, les yeux ouverts puis les yeux fermés.
- — *Normalement :* le sujet est capable de maintenir cette position les yeux ouverts et les yeux fermés.
- — *Les anomalies de la station debout* peuvent se voir en cas d'atteinte de la sensibilité proprioceptive, en cas d'atteinte vestibulaire et en cas d'atteinte cérébelleuse.

.L'*examen de l'équilibre comprend :*

- *la recherche d'un élargissement du polygone de sustentation.*
- *D'oscillations à la station debout les pieds joints les yeux ouverts, puis fermés.*
- *D'une déviation des index, d'une marche en étoile.*

ATAXIE VESTIBULAIRE

- Lors de la station debout, pieds joints, apparaît une inclinaison latérale, lente de l'axe du corps aggravée par la fermeture des yeux
- Cette déviation se fait toujours dans le même sens.
- C'est **le signe de Romberg labyrinthique : Romberg latéralisé ; pseudo Romberg**

Ataxie proprioceptif

- Mauvaise perception du sol
- Peu d'oscillations autour de la position d'équilibre.
- Pas de danse des tendons
- Chute brutale immédiate non latéralisée lors de la fermeture des yeux signe de Romberg proprioceptif. Position debout impossible les yeux fermée

Ataxie cérébelleuse

- Danse des tendons
- En position debout, le cérébelleux se tient les **jambes écartées (élargissement du polygone de sustentation),**
- Oscillations autour de la position d'équilibre se traduisant à l'inspection des pieds par le phénomène de danse des tendons des muscles tibiaux (jambiers) antérieurs.

- **Pas d'aggravation lors de la fermeture des yeux (pas de signe de Romberg)**

Manifestations	Résultats
Pas de déséquilibre	Normal
Oscillations du haut du corps dans toutes les directions, majorées par l'occlusion des yeux, avec possible chute sans latéralisation	C'est le **vrai signe de Romberg** qui traduit une atteinte dans **la sensibilité proprioceptive (ataxie statique sensitive)**. D'autres anomalies seront associées.
Oscillations du corps dans toutes les directions avec écartement des pieds (polygone de sustentation), non modifiées par occlusion des yeux. Possible chute sans latéralisation	Fait partie du syndrome cérébelleux statique **(ataxie statique cérébelleuse)**, encore appelé signe de **Romberg cérébelleux.**
Déviation du corps latéralisée avec chute très marquée après occlusion des yeux.	Syndrome vestibulaire **(ataxie statique vestibulaire),** encore appelé **signe de Romberg vestibulaire**

II. Examen de la marche

- *La marche doit être observée dès l'entrée du malade dans la salle de consultation.*
- *L'inspection de la marche se fera si possible pieds nus sur un sol dur, sur au moins une dizaine de mètres.*
- *L'analyse de la marche comprend:*
  - *l'attitude en position debout*
  - *le mouvement des bras et leur symétrie*
  - *le mouvement des membres inférieurs*
  - *la réalisation du demi-tour et la réaction du malade face à ses difficultés de marche.*

- **Marche normale:**

Marche stable, possible sur une ligne droite, les pas sont de taille égale, le demi tour ne provoque pas d'instabilité

- Principaux troubles de la marche d'origine neurologique:

Déficitaire (en fauchant, en steppant, myopathique)

Ataxique(cérébelleuse, vestibulaire, proprioceptive)

À petits pas.

Marche déficitaires

- ***démarche en fauchant : Atteinte du système pyramidal .***

- ***La démarche en steppant ou steppage***

atteinte du **nerf sciatique poplité externe** (SPE), dépendant lui-même principalement de **la racine L5: *steppage***

- **La *démarche dandinante*** ou démarche de canard est très caractéristique des myopathes .

Démarches ataxiques

- ***Ataxie vestibulaire :*** la marche est *précautionneuse et instable avec une déviation latérale de la ligne de marche*. déviation des index
- ***Ataxie cérébelleuse :***

A la marche, le sujet ne peut aller droit devant lui, il avance en décrivant des courbes alternativement à droite et à gauche : **en zigzague,** les jambes écartées, les bras en abduction. Lorsque les oscillations du corps sont plus marquées au cours de la progression de la marche, le cérébelleux titube, **réalisant la démarche ébrieuse**.

- ***Ataxie proprioceptive*** marche talonnante aggravée dans l'obscuritée et fermeture des yeux

- Baptiste coustet. Sémiologie médicale: l'apprentissage pratique de l'examen clinique. 2008 éditions Estem
- Examen clinique et sémiologie : l'essentiel. 1re édition, de Nicholas J. Talley et Simon O'Connor. Révision française du texte : Dr Olivier Allain © 2017 Elsevier Masson SAS
- Précis de sémiologie

MERCI